REP BLICA DE ANGOLA

MINIST RIO DA SA DE CONCURSO P BLICO DE INGRESSO EXTERNO

CARREIRA DE APOIO HOSPITALAR

MANUAL DE APOIO AO ESTUDO

SECRET RIO CL NICO

Programa oficial completo, com legisla o, indicadores, racioc nio e quest es no formato de prova

- I. Organiza o da Administra o P blica
- II. Pauta Deontol gica da Fun o P blica
- III. Racioc nio Verbal
- IV. Racioc nio Num rico
- V. COVID-19
- VI. Cultura Geral
- VII. Divis o Pol tico-Administrativa (2024/2025)
- VIII. Censo Populacional 2024
- IX. IIMS 2023 2024
- X. Intelig ncia Artificial

EDI O DE ESTUDO 2026

Material de apoio pedag gico N o substitui a legisla o oficial nem os t picos publicados pelo MINSA

REP BLICA DE ANGOLA
MINIST RIO DA SA DE
Direc o Nacional de Recursos Humanos apoio ao candidato

Manual de Apoio ao Estudo

Concurso P blico de Ingresso Externo Carreira de Apoio Hospitalar

Categoria: Secret rio Cl nico

Este volume cobre, ponto por ponto, o programa publicado nos t picos oficiais: organiza o da Administra o P blica; pauta deontol gica; racioc nio verbal e num rico; COVID-19; cultura geral; divis o pol tico-administrativa de 2024/2025; Censo 2024; IIMS 2023 2024; e Intelig ncia Artificial. Inclui quadros de memoriza o, 45 quest es tipo prova e chave comentada.

Os n meros demogr ficos e sanit rios reproduzem fontes oficiais do INE e do MINSA dispon veis data de elabora o (resultados definitivos do RGPH 2024 e IIMS 2023 2024). Se o Minist rio publicar rectifica o estat stica posterior, prevalece o documento oficial.

FUNDAMENTO LEGAL

Portal de candidaturas e t picos: concurso-minsa.ao sigrh.minsa.gov.ao info.rh@minsa.gov.ao Av. 21 de Janeiro, Gamek, Edif cio Sede, r s-do-ch o, Luanda.

NDICE

Como usar este manual e o perfil do Secret rio Cl nico	4
I. No es gerais sobre a organiza o da Administra o P blica	6
II. Pauta Deontol gica da Fun o P blica	12
III. Racioc nio verbal	18
IV. Racioc nio num rico	24
V. COVID-19	30
VI. Cultura geral	36
VII. Divis o pol tico-administrativa de Angola (2024)	42
VIII. Censo Populacional de Angola 2024	48
IX. Inqu rito de Indicadores M ltiplos e de Sa de (IIMS 2023 2024)	54
X. Intelig ncia Artificial	60
Bateria de quest es tipo prova (com resolu o)	66
Folha de respostas e chave	76
Fontes e legisla o de consulta	78

DICA DE PROVA

A prova do MINSA mistura conhecimentos gerais da Fun o P blica, actualidade angolana (DPA, Censo, IIMS) e racioc nio. Estude primeiro os n meros e as leis assinalados nas caixas verdes s o os itens mais cobrados em concursos de ingresso.

COMO USAR ESTE MANUAL

Este manual foi elaborado para o candidato ao concurso p blico de ingresso externo do Minist rio da Sa de (MINSA), carreira de Apoio Hospitalar Secret rio Cl nico, segundo os t picos oficiais publicados pela Direc o Nacional de Recursos Humanos. N o um diploma legal nem um formul rio de inscri o: um instrumento de estudo, organizado para memoriza o, compreens o e treino.

Como estudar (plano de 14 dias)

Dias 1 2. Administra o P blica + Pauta Deontol gica. Decore princ pios, deveres e diplomas (CRA, Lei n. 26/22, Resolu o n. 27/94, Lei n. 3/10).

Dias 3 4. Cultura geral de Angola e Divis o Pol tico-Administrativa: 21 prov ncias, sedes, n meros 326/378 e as 3 novas prov ncias.

Dias 5 6. Censo 2024 e IIMS 2023 2024. Memorize indicadores (popula o, urbaniza o, mortalidade, nutri o, vacina o).

Dias 7 8. COVID-19 e Intelig ncia Artificial, com nfase em conceitos, tica e protec o de dados no hospital.

Dias 9 11. Racioc nio verbal e num rico: fa a todos os exerc cios sem consultar as respostas.

Dias 12 13. Simulado completo no tempo (60 90 minutos, conforme o edital).

Dia 14. Revis o s das caixas MEMORIZE e dos erros do simulado.

O que faz o Secret rio Cl nico

O secret rio cl nico o profissional de apoio hospitalar que organiza o fluxo administrativo da unidade sanit ria: recep o e encaminhamento de utentes, marca o de consultas e exames, abertura e arquivo do processo cl nico, transcri o e organiza o de documenta o m dica, estat stica simples de produ o, e apoio comunica o entre servi os. Actua na interface entre o cidad o e a equipa de sa de, pelo que sigilo, urbanidade e rigor documental s o compet ncias nucleares.

Atendimento e informa o ao utente (com urbanidade e imparcialidade).

Registo de dados pessoais e cl nicos sempre com dever de protec o e sigilo.

Organiza o da agenda cl nica e da lista de espera.

Prepara o de guias, relat rios, mapas estat sticos e correspond ncia oficial.

Arquivo activo e morto do processo cl nico, segundo as normas da unidade.

Apoio factura o, s altas e articula o com outros servi os (laborat rio, internamento, farm cia).

ATEN O

O secret rio cl nico n o diagnostica, n o prescreve e n o divulga informa o cl nica a terceiros. Qualquer pedido de dados de doentes (incluindo familiares, jornalistas ou autoridades sem compet ncia legal) deve ser encaminhado direc o cl nica ou ao respons vel pelo processo, nos termos da lei.

I. NO ES GERAIS SOBRE A ORGANIZA O DA ADMINISTRA O P BLICA

1. Conceito e finalidade

A Administra o P blica o conjunto de rg os, servi os e agentes que, sob a direc o pol tica do Estado, asseguram a satisfa o das necessidades colectivas (sa de, educa o, seguran a, justi a, infra-estruturas). N o se confunde com o Governo (rg o pol tico): a Administra o executa as pol ticas p blicas, no respeito pela Constitui o e pela lei.

Nos termos do artigo 198. da Constitui o da Rep blica de Angola (CRA), a Administra o P blica estruturada com base nos princ pios da simplifica o administrativa, da aproxima o dos servi os s popula es e da desconcentra o e descentraliza o administrativas.

FUNDAMENTO LEGAL

CRA, T tulo V (Administra o P blica): arts. 198. (princ pios), 198. -A (mbito), 199. (estrutura), 200. (direitos dos administrados), 200. -A (Administra o Central). Lei n. 26/22, de 22 de Agosto Lei de Bases da Fun o P blica (revogou a Lei n. 17/90).

2. mbito da Administra o P blica (art. 198. -A da CRA)

Administra o Directa do Estado minist rios, servi os centrais e rg os desconcentrados (ex.: Gabinetes Provinciais de Sa de) sujeitos ao poder de direc o do Titular do Poder Executivo.

Administra o Indirecta do Estado institutos p blicos, fundos e empresas p blicas que prosseguem fins do Estado com autonomia administrativa e, em regra, financeira.

Administra o Aut noma entes com autonomia pr pria (poder local / autarquias, quando institu das).

Administra o Independente entidades administrativas independentes, com garantia de isen o (reguladores, rg os de garantia).

3. Administra o Central e Local

A Administra o Central (art. 200. -A) integra os rg os e servi os sujeitos direc o e superintend ncia do Titular do Poder Executivo. As suas atribui es abrangem todo o territ rio nacional. A Administra o Local do Estado exercida pelos governos provinciais e pelas administra es municipais, que representam o Executivo no territ rio e asseguram a execu o das pol ticas sectoriais incluindo a sa de.

No sector da sa de, a cadeia t pica : MINSA (pol tica nacional) Gabinetes Provinciais de Sa de Direc es / Administra es Municipais de Sa de unidades sanit rias (hospitais, centros e postos de sa de). O secret rio cl nico insere-se na ltima linha, mas est vinculado a toda a hierarquia administrativa.

4. Princ pios da Fun o P blica (Lei n. 26/22, art. 6.)

A Lei de Bases da Fun o P blica enumera os princ pios que o candidato deve saber reconhecer e distinguir. Em prova, o enunciado costuma descrever uma situa o e pedir o princ pio violado ou aplicado.

Princ pio	Ideia-chave para a prova
Interesse p blico	O interesse colectivo prevalece sobre o interesse particular do funcion rio ou de terceiros.
tica e deontologia	A conduta profissional obedece a deveres morais e profissionais, para al m da lei formal.
Igualdade	Tratamento igual de situa es iguais; proibi o de discrimina o.
Legalidade	S se pode actuar nos termos da Constitui o, da lei e dos regulamentos.

Princ pio	Ideia-chave para a prova
Justi a	Decis es equitativas, sem arb trio.
Proporcionalidade	Os meios usados devem ser adequados, necess rios e equilibrados face ao fim.
Imparcialidade	Isen o pol tica, econ mica, religiosa ou pessoal.
Responsabiliza o	O agente responde pelos seus actos e omiss es.
Probidade administrativa	Honestidade, lisura e recusa de vantagens indevidas.
Respeito pelo patrim nio p blico	Bens do Estado n o se usam em proveito pr prio.
Efici ncia e efic cia	Fazer bem (qualidade) e alcan ar resultados (fins).
Rigor	Exactid o no cumprimento das tarefas e no tratamento da informa o.
Transpar ncia e publicidade	Actos acess veis e publicitados, salvo segredo legal.
Finalidade	Os poderes s podem ser usados para o fim para que foram conferidos (proibi o do desvio de poder).
Motiva o	Os actos administrativos devem ser fundamentados.
Moralidade	Conformidade com a tica p blica e os bons costumes administrativos.
Racionalidade	Uso racional dos recursos e dos procedimentos.
Seguran a jur dica	Estabilidade e previsibilidade das decis es.
Responsabilidade profissional	Compet ncia t cnica e assun o das consequ ncias do exerc cio.
Urbanidade	Cortesia no trato com utentes, colegas e hierarquia.
Respeito pelos direitos dos particulares e ampla defesa	O cidad o ouvido e pode defender-se.

Quadro 1 Princ pios do art. 6. da Lei n. 26/22.

MEMORIZE PARA A PROVA

N o confunda efic cia (atingir o resultado) com efici ncia (atingir o resultado com o menor desperd cio de recursos). N o confunda desconcentra o (o Estado reparte compet ncias pelos seus pr prios rg os, mantendo a hierarquia) com descentraliza o (transfere compet ncias para entes com personalidade jur dica pr pria).

5. Miss o e objectivos da Fun o P blica

Nos termos dos arts. 3. e 5. da Lei n. 26/22, a miss o prestar servi o p blico Na o, considerando o utente como elemento central, optimizar recursos e modernizar a gest o. Objectivos: servi o de qualidade com cultura de servi o p blico; melhoria cont nua; bem-estar dos funcion rios e efici ncia profissional.

6. V nculo, ingresso e conceitos-chave (arts. 4. e 10. 13.)

Funcion rio pessoa com v nculo de emprego p blico por nomea o (regra de ingresso).

Agente administrativo ingressa por nomea o provis ria ou por contrato de trabalho p blico.

Carreira conjunto hierarquizado de categorias da mesma natureza.

Categoria posi o do funcion rio na carreira, segundo o conte do funcional.

Quadro de pessoal documento que fixa carreiras, categorias e n mero de postos.

O ingresso faz-se, em regra, por concurso p blico. A nomea o a regra; o contrato de trabalho p blico excepcional.

7. Direitos do funcion rio (art. 9.) s ntese

Desempenho efectivo das fun es da carreira; progress o e promo o por m rito.

Justa remunera o; forma o inicial e cont nua; f rias e licen as.

Seguran a, higiene e sa de no trabalho; protec o social.

Dignidade, intimidade e urbanidade por parte dos superiores.

Consulta do processo individual; n o ser punido sem audi ncia pr via.

Direito greve e filia o sindical, nos termos da lei.

8. Direitos e garantias dos administrados (art. 200. da CRA)

O cidad o tem direito a ser ouvido nos processos que o afectem, a ser informado sobre o andamento e a conhecer as decis es. No hospital, isto traduz-se em informa o clara sobre hor rios, documentos exigidos, filas, resultados (pelo profissional competente) e vias de reclama o sem quebrar o sigilo cl nico.

9. O MINSA no aparelho do Estado

O Minist rio da Sa de o departamento ministerial respons vel pela pol tica nacional de sa de e pela tutela do Servi o Nacional de Sa de (SNS). A Ministra da Sa de a Dra. S lvia Paula Valentim Lutucuta. O concurso organizado pela Direc o Nacional de Recursos Humanos. Contactos oficiais de refer ncia nos t picos: Av. 21 de Janeiro, Gamek, Edif cio Sede (r s-do-ch o), Luanda; info.rh@minsa.gov.ao; sigrh.minsa.gov.ao / concurso-minsa.ao.

DICA DE PROVA

Se a pergunta falar em rg os de soberania , recorde: Presidente da Rep blica, Assembleia Nacional, Tribunais e (no desenho constitucional angolano) os demais rg os previstos na CRA. O MINSA n o rg o de soberania rg o da Administra o Central do Estado.

II. PAUTA DEONTOL GICA DA FUN O P BLICA

1. O que deontologia

Deontologia (do grego deon, dever) o conjunto de deveres ticos de uma profiss o. Na Fun o P blica, a deontologia transforma a obriga o legal em devo o ao interesse p blico: o funcion rio n o se limita a n o violar a lei ; serve o cidad o com justi a, transpar ncia e tica, para criar confian a entre o Estado e a sociedade.

FUNDAMENTO LEGAL

Diploma-base da pauta: Resolu o n. 27/94, de 26 de Agosto (Pauta Deontol gica do Servi o P blico), aprovada no Governo do Primeiro-Ministro Marcolino Moco. Complementam-na a Lei n. 26/22 (deveres do art. 7.) e a Lei n. 3/10, de 29 de Mar o (Lei da Probidade P blica).

2. mbito, conte do e aplica o (Resolu o n. 27/94, I)

Abrange todos os trabalhadores da Administra o P blica, qualquer que seja o cargo, o n vel ou o local incluindo dirigentes.

Cont m deveres tico-profissionais e sociais nas rela es com os cidad os, com entidades particulares e com os rg os do Estado.

A sua aplica o n o dispensa regras deontol gicas espec ficas de cada institui o (no hospital: sigilo cl nico, normas de infec o, regulamento interno).

3. Valores essenciais da Pauta (n. s 4 a 8)

N mero / valor	Conte do essencial
4. Interesse p blico	Fun es exercidas exclusivamente ao servi o do interesse colectivo. Os interesses gerais s o a raz o de ser ltima da actua o p blica.
5. Legalidade	Actuar sempre em conformidade com a lei; conhecer leis e regulamentos; contribuir para a consci ncia jur dica dos cidad os.
6. Neutralidade	Imparcialidade e objectividade; igualdade de todos perante a lei; recusa de crit rios pol ticos, econ micos ou religiosos.
7. Integridade e responsabilidade	Verticalidade, discri o, lealdade e transpar ncia, para aumentar a confian a nas institui es.
8. Compet ncia	M rito, brio e efici ncia como crit rios de profissionalismo; a qualidade do servi o depende da capacita o permanente.

Quadro 2 Valores essenciais da Resolu o n. 27/94.

4. Deveres para com os cidad os (n. s 9 a 13)

9. Qualidade na presta o do servi o bem servir, com efici ncia, rigor e humanidade.

10. Isen o e imparcialidade todos os cidad os s o iguais perante a lei; mesmo atendimento, mesmo encaminhamento.

11. Compet ncia e proporcionalidade meios t cnicos adequados e proporcionais ao fim.

12. Cortesia e informa o trato cort s e dever de esclarecer o cidad o.

13. Probidade proibi o de solicitar ou aceitar presentes, empr stimos, facilidades ou quaisquer ofertas que comprometam a independ ncia e a credibilidade da Administra o.

5. Deveres especiais para com a Administra o (n. s 14 a 19)

14. Servi o p blico o interesse geral prevalece; vedado usar o cargo para fins particulares.

15. Dedica o esp rito de miss o, prontid o, racionalidade e efic cia; respeito pela hierarquia e criatividade na resolu o de problemas.

16. Autoforma o, aperfei oamento e actualiza o conhecer a lei e actualizar-se permanentemente (os chefes devem ser exemplo).

17. Reserva e discri o n o divulgar factos conhecidos em servi o nem us -los em proveito pr prio ou de terceiros.

18. Parcim nia uso criterioso dos bens p blicos; proibi o de desperd cio e de uso pessoal.

19. Solidariedade e coopera o esp rito de equipa e entreajuda.

6. Deveres para com os rg os de soberania (n. s 20 e 21)

20. Zelo e dedica o independentemente das convic es pol ticas ou ideol gicas, agir com efici ncia e objectividade, respeitando os direitos fundamentais.

21. Lealdade executar com lealdade os programas e miss es superiores, no respeito escrupuloso lei e s ordens leg timas dos superiores.

ATEN O

O dever de obedi ncia n o cobre ordens criminosas. A Lei n. 26/22 esclarece: n o existe dever de obedi ncia quando esta implicar a pr tica de crime. O subordinado deve tentar demover o superior. Na secretaria cl nica, isto aplica-se a pedidos de falsificar registos, desaparecer processos ou vender vagas de consulta.

7. Deveres da Lei n. 26/22 (art. 7.) lista de memoriza o

A prova pode pedir o nome exacto do dever. Memorize os onze deveres positivos e as quatro proibi es:

Dever (art. 7. , n. 1)	Tradu o pr tica no hospital
Respeito aos s mbolos nacionais e institui es	Uso correcto da bandeira, hino, armas e dignidade das institui es.
Proteger os dados pessoais	Especialmente relevante no hospital (processo cl nico, BI, telefone, diagn stico).
Obedi ncia	Constitui o, leis, regulamentos e ordens leg timas de servi o.
Lealdade	Subordina o aos objectivos do servi o e ao interesse p blico.
Neutralidade / isen o	Imparcialidade pol tica, econ mica, social ou outra.
Discri o	Sigilo dos factos n o p blicos conhecidos em servi o; segredo profissional.
Parcim nia	Proteger e conservar os bens do Estado; nada de uso particular.
Assiduidade	Comparecer regular e continuamente.
Pontualidade	Cumprir o hor rio.
Urbanidade	Respeito a utentes, colegas, chefes e subordinados.
Zelo	Conhecer as normas e aperfei oar a t cnica para exercer com efici ncia.

Quadro 3 Deveres do funcion rio e aplica o na secretaria cl nica.

O n. 2 do art. 7. pro be ainda: conflitos de interesses; obten o de vantagens indevidas pelo cargo; uso de informa o privilegiada; press o, amea a ou ass dio moral ou sexual a colegas, subordinados ou utentes.

8. Probidade p blica (Lei n. 3/10)

A Lei da Probidade P blica exige do agente p blico legalidade, compet ncia, respeito pelo patrim nio, imparcialidade, interesse p blico, responsabilidade, urbanidade, reserva, parcim nia e lealdade. Constitui improbidade a ac o ou omiss o que viole estes deveres, bem como o enriquecimento il cito e os actos que prejudiquem o patrim nio p blico.

MEMORIZE PARA A PROVA

Tr s diplomas que caem quase sempre: Resolu o n. 27/94 (pauta), Lei n. 26/22 (bases da Fun o P blica) e Lei n. 3/10 (probidade). Relacione cada situa o pr tica a um dever: oferta de um agasalho = probidade; chegar tarde = pontualidade; comentar o diagn stico do doente no candongueiro = discri o / dados pessoais / sigilo.

9. Deontologia aplicada ao Secret rio Cl nico

Chamar o utente pelo nome, sem gritar diagn sticos na fila.

N o furar a fila de familiares, conhecidos ou chefes imparcialidade.

N o fotografar processos nem partilhar listagens em grupos de WhatsApp.

N o aceitar dinheiro para acelerar uma marca o.

Cuidar da impressora, papel, computadores e selos da institui o (parcim nia).

Manter o posto de trabalho organizado e o arquivo recuper vel (zelo).

Tratar com igual respeito o doente pobre, o idoso, a gr vida e o dirigente.

III. RACIOC NIO VERBAL

O t pico oficial pede capacidade para interpretar, resolver problemas com opera es verbais simples e demonstrar conhecimento do vocabul rio portugu s. N o uma prova de literatura: uma prova de leitura atenta, l gica da l ngua e precis o lexical.

1. Interpreta o de texto

Leia o texto duas vezes. Na primeira, capte o tema e o tom (informativo, argumentativo, normativo). Na segunda, sublinhe: sujeito das ac es, n meros, nega es (n o , salvo , exceto/excepto), e o que o texto n o diz. As op es incorrectas costumam: generalizar demais; inverter a causa e o efeito; usar palavras absolutas (sempre , nunca , todos) que o texto n o autoriza; ou trazer informa o verdadeira mas externa ao texto.

Texto de treino A

A Administra o P blica visa a prossecu o do interesse p blico, no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidad os. Os rg os e agentes administrativos est o subordinados lei e devem actuar com justi a e imparcialidade. O utente n o um estorvo da secretaria: a raz o de ser do servi o. Por isso, a qualidade do atendimento mede-se tanto pelo cumprimento dos prazos como pela urbanidade com que se trata a pessoa que espera.

1. Segundo o Texto A, correcto afirmar que:

A) O interesse p blico autoriza o agente a ignorar os direitos dos cidad os.

B) A qualidade do atendimento combina cumprimento de prazos e urbanidade.

C) A imparcialidade facultativa quando h urg ncia de servi o.

D) O utente s deve ser atendido depois de resolvidos os assuntos internos.

E) A subordina o lei aplica-se apenas aos dirigentes.

2. Vocabul rio: sin nimos, ant nimos e precis o

Em prova, pe a-se o sin nimo no contexto. Pauta pode ser norma de conduta (deontologia) ou lista de assuntos. Processo pode ser o conjunto de pap is do doente ou o procedimento administrativo. Alta no hospital n o pre o elevado .

Termo	Sentido usual na prova	Contraste til
Deontologia	Conjunto de deveres ticos de uma profiss o	Amoralidade / arb trio
Imparcialidade	Isen o; aus ncia de favoritismo	Parcialidade / favorecimento
Probidade	Honestidade; integridade no cargo	Improbidade / corrup o
Parcim nia	Uso moderado e cuidadoso dos recursos	Esbanjamento / desperd cio
Assiduidade	Comparecimento regular ao servi o	Absentismo
Urbanidade	Cortesia e boa educa o no trato	Grosseria / descortesia
Zelo	Cuidado diligente e competente	Neglig ncia / desleixo
Sigilo	Dever de guardar segredo	Indiscri o / divulga o
Desconcentra o	Repartir compet ncias na mesma pessoa colectiva	Concentra o
Descentraliza o	Transferir compet ncias a ente aut nomo	Centraliza o
Efic cia	Capacidade de atingir o resultado	Inefic cia
Efici ncia	Atingir o resultado com bom uso de meios	Desperd cio / inefici ncia
Utente	Utilizador do servi o p blico	Prestador / agente
Progn stico	Previs o da evolu o de uma doen a	Diagn stico (identifica o)
Etiologia	Causa / origem de uma doen a	Sintomatologia

Termo	Sentido usual na prova	Contraste til
Preval ncia	Casos existentes num momento	Incid ncia (casos novos)
Censo	Contagem oficial da popula o	Sondagem / amostra
Comuna	Unidade territorial abaixo do munic pio	Prov ncia
Aloca o	Atribui o de recursos	Confisco
Motiva o (acto)	Fundamenta o da decis o	Arbitrariedade

Quadro 4 Vocabul rio de alta incid ncia.

3. Analogias verbais

A analogia pede a mesma rela o l gica. Identifique a rela o do par-base (causa efeito, parte todo, agente instrumento, grau, ant nimo, lugar habitante) e aplique-a ao segundo par.

M DICO est para DIAGN STICO como JUIZ est para SENTEN A (acto pr prio da fun o).

HOSPITAL est para DOENTE como ESCOLA est para ALUNO (institui o utente).

SIGILO est para DIVULGA O como PROBIDADE est para CORRUP O (ant nimos de dever).

PROV NCIA est para GOVERNADOR como MUNIC PIO est para ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

4. Ortografia e vocabul rio da norma usada na Administra o angolana

Os documentos oficiais angolanos conservam, em regra, a grafia tradicional: objectivo, ac o, colec o, direc o, protec o, car cter, facto, acto, actual, ptimo, electr nico, concep o. Em prova, se o texto oficial usar essa grafia, n o a corrija para a do Acordo Ortogr fico de 1990. Aten o ainda a: h (tempo decorrido) (a+a); mau (adjectivo) mal (adv rbio); sen o (caso contr rio / a n o ser) se n o (condi o negativa); acerca de (sobre) h cerca de (aproximadamente).

5. Coer ncia, coes o e opera es verbais simples

Opera es verbais t picas: completar um per odo com o conector certo (por m, portanto, porque, embora, conforme, salvo); identificar o referente de um pronome; ordenar frases; detectar contradi o; escolher o t tulo que resume o texto. Portanto introduz conclus o; porque introduz causa; embora introduz concess o; salvo introduz excep o.

Texto de treino B

O processo cl nico o conjunto de documentos que registam a identidade, a hist ria, os exames, o tratamento e a evolu o do doente. N o propriedade do profissional que o preenche: pertence institui o e serve o doente. O secret rio que extravia um processo, ou que o mostra a quem n o tem legitimidade, fere ao mesmo tempo o zelo, a discri o e a protec o de dados.

2. No Texto B, a express o n o propriedade do profissional que o preenche significa que:

A) O m dico n o pode escrever no processo.

B) O processo pode ser levado para casa pelo secret rio, por ser da institui o.

C) O documento institucional n o fica disposi o particular de quem o elabora.

D) S o doente pode consultar o processo, nunca a equipa de sa de.

E) O processo deixa de existir depois da alta.

6. Quest es de treino verbal

3. Assinale o par em que a rela o a mesma de LEGALIDADE / ILEGALIDADE:

A) Hospital / enfermagem

B) Probidade / improbidade

C) Consulta / marca o

D) Prov ncia / comuna

E) Censo / popula o

4. O funcion rio deve tratar com igual aten o o ministro e o campon s. O princ pio mais directamente ilustrado :

A) Parcim nia

B) Hierarquia

C) Imparcialidade / igualdade

D) Motiva o do acto

E) Desconcentra o

5. Qual das frases est correcta quanto ao sentido dos termos cl nicos?

A) A etiologia descreve a previs o da cura.

B) O progn stico indica a causa da doen a.

C) O diagn stico identifica a doen a; o progn stico estima a sua evolu o.

D) A preval ncia conta apenas os casos novos do ano.

E) Incid ncia e preval ncia s o sin nimos perfeitos.

6. Em salvo disposi o legal em contr rio , a palavra salvo exprime:

A) Causa

B) Conclus o

C) Excep o

D) Tempo

E) Compara o

7. Sin nimo contextual de pauta deontol gica :

A) Lista de vencimentos

B) Norma de deveres ticos do servi o p blico

C) Hor rio de expediente

D) Mapa de f rias

E) Or amento do minist rio

DICA DE PROVA

T cnica de 40 segundos: leia a pergunta antes do texto longo, para saber o que procurar; elimine duas op es absurdas; desconfie da op o que reproduz uma frase do texto mas muda um quantificador (todos/alguns, sempre/em regra).

IV. RACIOC NIO NUM RICO

O t pico pede capacidade para interpretar e resolver problemas com opera es num ricas. No concurso do MINSA, os n meros v m muitas vezes disfar ados de situa o hospitalar ou de indicador sanit rio. Domine as quatro opera es, percentagens, regra de tr s, m dias, raz es e leitura de tabelas.

1. Opera es e ordem

Ordem: par nteses pot ncias multiplica o e divis o (da esquerda para a direita) adi o e subtrac o. Converta sempre as unidades antes de calcular (horas em minutos, kwanzas em milhares, milhares em milh es).

2. Fra es, raz es e propor es

Uma raz o compara duas grandezas (3 enfermeiros para 45 doentes = 3:45 = 1:15). Uma propor o afirma que duas raz es s o iguais: a/b = c/d, donde a d = b c (produtos cruzados). A regra de tr s simples resolve a quarta proporcional. Se as grandezas forem directamente proporcionais (mais horas mais fichas registadas), a seta vai no mesmo sentido. Se forem inversamente proporcionais (mais funcion rios menos dias para o mesmo arquivo), inverte-se uma raz o.

3. Percentagens

x% de N = (x/100) N. Aumentar 20% multiplicar por 1,20; reduzir 20% multiplicar por 0,80. Cuidado: subir 20% e depois descer 20% n o volta ao valor inicial (100 120 96). A varia o percentual ((final inicial) / inicial) 100.

MEMORIZE PARA A PROVA

F rmulas que caem em prova de sa de: taxa = (casos / popula o) 1 000 (ou 100 000, conforme o indicador). Ocupa o de camas = (doentes internados / camas dispon veis) 100. M dia = soma / n. Se a prova der 32 bitos por 1 000 nados-vivos , em 5 000 nados-vivos espera 32 5 = 160 bitos.

4. M dias e interpreta o de tabelas

A m dia aritm tica esconde desigualdades: a m dia nacional de um indicador pode ser puxada por Luanda. Quando a tabela tiver urbano / rural , calcule cada linha parte. Leia o cabe alho das unidades (milh es, %, por 1 000).

5. Problemas resolvidos (modelo de prova)

Problema 1. Uma unidade atendeu 240 utentes. Destes, 15% eram crian as. Quantas crian as foram atendidas?

Resolu o: 15% de 240 = 0,15 240 = 36 crian as.

Problema 2. O arquivo tem 1 800 processos. Tr s secret rios arquivam mesma velocidade e terminam em 12 dias. Em quantos dias terminam quatro secret rios, no mesmo ritmo?

Resolu o (inversa): 3 12 = 4 d d = 36/4 = 9 dias.

Problema 3. Em 2014 a popula o era 25 789 024 e em 2024 era 36 604 681. O acr scimo absoluto foi 10 815 657 (arredondado nos relat rios a 10 815 656). A taxa m dia anual anunciada pelo INE de 3,5%. N o tente adivinhar a taxa com uma divis o simples do total por 10: a taxa m dia anual composta. Na prova, use o valor oficial se ele for pedido como conhecimento; se for pedido o acr scimo absoluto, subtraia.

Problema 4. Taxa de mortalidade infantil = 32 por 1 000. Num munic pio com 2 500 nados-vivos, o n mero esperado de bitos infantis 32 2,5 = 80.

Problema 5. Um hospital tem 80 camas. Est o ocupadas 68. Taxa de ocupa o = (68/80) 100 = 85%.

Problema 6. O vencimento de 150 000 Kz sofre um desconto de 8% e um abono de 12 000 Kz. L quido = 150 000 0,92 + 12 000 = 138 000 + 12 000 = 150 000 Kz.

6. Quest es de treino num rico

8. 30% de 450 igual a:

A) 90

B) 120

C) 135

D) 150

E) 180

9. Uma farm cia hospitalar tinha 200 frascos. Usou 35% e recebeu depois 40 frascos. Quantos tem agora?

A) 110

B) 130

C) 150

D) 170

E) 180

10. Se 5 secret rios registam 400 fichas em 8 horas, quantas fichas registam 10 secret rios em 4 horas, no mesmo ritmo?

A) 200

B) 300

C) 400

D) 500

E) 800

11. A m dia das idades 18, 22, 25, 19 e 26 :

A) 20

B) 21

C) 22

D) 23

E) 24

12. Um indicador passou de 40 para 52. A varia o percentual foi de:

A) 12%

B) 23%

C) 30%

D) 52%

E) 70%

13. Numa enfermaria com 40 camas, a ocupa o 70%. O n mero de camas livres :

A) 10

B) 12

C) 14

D) 18

E) 28

14. A raz o 2:5 equivale, em percentagem do primeiro sobre o total, a:

A) 20%

B) 25%

C) 28,6%

D) 40%

E) 50%

15. Se a taxa 16 bitos neonatais por 1 000 nados-vivos, em 12 500 nados-vivos o n mero esperado :

A) 16

B) 125

C) 160

D) 200

E) 250

DICA DE PROVA

Leve para a prova o h bito de estimar antes de calcular. Se 30% de 450 cheira a pouco mais de 130, a op o 90 est fora. Confira sempre a unidade (por 1 000 ou por 100 000) e se a pergunta pede o valor restante ou o valor gasto.

V. COVID-19

O programa pede o tema nas al neas a) a h). Estude-as nessa ordem: a prova costuma seguir o gui o.

a) Conceito

A COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) uma doen a infecciosa aguda, predominantemente respirat ria, causada pelo coronav rus SARS-CoV-2, identificada pela primeira vez em Wuhan (China) em Dezembro de 2019 e declarada pandemia pela OMS em 11 de Mar o de 2020. Pode variar de infec o assintom tica at pneumonia grave e fal ncia de rg os. Transmite-se sobretudo por got culas e aeross is das vias respirat rias e, em menor grau, por contacto com superf cies contaminadas (f mites).

b) Etiologia

O agente etiol gico o SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2), v rus de ARN da fam lia Coronaviridae, g nero Betacoronavirus. Entra nas c lulas humanas principalmente pela liga o da prote na Spike (S) ao receptor ECA2 (enzima conversora da angiotensina 2), abundante no epit lio respirat rio. O v rus sofreu evolu o em variantes (Alpha, Beta, Delta, micron e sublinhagens), com diferen as de transmissibilidade e escape imunit rio. Reservat rio original: provavelmente zoon tico (morcegos, com poss vel hospedeiro intermedi rio).

c) Quadro cl nico

O per odo de incuba o situa-se, em regra, entre 2 e 14 dias (mais frequentemente 3 6 dias nas variantes recentes). Espectro:

Assintom tico infec o comprovada laboratorialmente, sem sintomas.

Sintomas comuns febre, tosse seca, fadiga, odinofagia (dor de garganta), coriza, cefaleias, mialgias, diarreia, anosmia (perda de olfacto) e ageusia (perda de paladar).

Sinais de gravidade dispneia, satura o de oxig nio baixa, dor ou press o no t rax, confus o, l bios ou unhas cian ticos, redu o da diurese.

Crian as: em geral doen a mais ligeira; raro o s ndrome inflamat rio multissist mico (MIS-C).

Idosos e doentes com comorbilidades (hipertens o, diabetes, obesidade, DPOC, cancro, imunodepress o, gravidez de risco) t m maior probabilidade de formas graves.

d) Classifica o

Forma	Crit rio pr tico
Ligeira / leve	Sintomas de vias a reas superiores ou gerais, sem pneumonia e sem hipoxemia.
Moderada	Pneumonia sem sinais de gravidade; SpO habitualmente 90 94% em ar ambiente (limiares segundo protocolo vigente).
Grave	Pneumonia com taquipneia, tiragem, SpO baixa ou infiltrados extensos.
Cr tica	S ndrome de dificuldade respirat ria aguda (SDRA/ARDS), s psis, choque, fal ncia multiorg nica, necessidade de UCI / ventila o.
Long COVID / condi o p s-COVID	Sintomas persistentes ou novos para al m de 12 semanas (fadiga, dispneia, n voa mental, palpita o).

Quadro 5 Classifica o cl nica da COVID-19 (s ntese OMS / protocolos cl nicos).

e) Crit rios de diagn stico

O diagn stico combina cl nica + epidemiologia + laborat rio (e, se indicado, imagem):

Caso suspeito sintomatologia compat vel e/ou contacto com caso confirmado / v nculo epidemiol gico.

Caso prov vel cl nico e epidemiol gico forte, por vezes com imagem t pica, sem confirma o laboratorial.

Caso confirmado detec o do SARS-CoV-2 por teste laboratorial validado.

RT-PCR (hissope nasofar ngeo/orofar ngeo) padr o de refer ncia.

Teste r pido de antig nio til no ponto de cuidados; um negativo em doente muito suspeito deve ser interpretado com cautela.

Serologia (IgM/IgG) n o diagnostica infec o aguda de forma isolada; serve sobretudo para estudos de seropreval ncia.

Imagem radiografia ou TC de t rax com opacidades em vidro despolido, quando h compromisso pulmonar.

No hospital, o secret rio cl nico deve garantir a identifica o correcta do utente, o registo de contactos e a circula o da requisi o / resultado sem quebrar o sigilo.

f) Complica es

Pneumonia e SDRA / insufici ncia respirat ria.

Tromboembolismo (TVP, embolia pulmonar), AVC, enfarte a COVID-19 pr -tromb tica.

Les o mioc rdica, arritmias, miocardite.

Les o renal aguda, altera es hep ticas.

Sobreinfec o bacteriana, s psis e choque.

Descompensa o de doen as cr nicas (diabetes, asma, insufici ncia card aca).

Complica es da imobilidade e da UCI (lceras, del rio, polineuropatia).

Long COVID e impacto psicossocial (ansiedade, luto, estigma).

g) Conduta

A conduta segue o protocolo nacional vigente (MINSA / OMS) e o n vel da unidade. Princ pios est veis:

Preven o vacina o, higiene das m os, etiqueta respirat ria, ventila o, m scara em contextos de risco, isolamento de casos e quarentena de contactos conforme as regras em vigor.

Casos ligeiros isolamento, sintom ticos (antit rmicos), hidrata o, vigil ncia de sinais de alarme; evitar antibi ticos sem indica o (a COVID-19 viral).

Casos moderados/graves oxigenoterapia, corticoides quando h necessidade de O (ex. dexametasona, segundo protocolo), tromboprofilaxia, tratamento de comorbilidades, eventual antiviral conforme disponibilidade e crit rios (ex. nirmatrelvir/ritonavir, remdesivir segundo normas actualizadas).

Casos cr ticos UCI, ventila o n o invasiva ou mec nica, suporte hemodin mico.

Notifica o doen a de declara o obrigat ria enquanto assim estiver classificada; o secret rio apoia o preenchimento correcto das fichas.

Biosseguran a na secretaria n o triar de ouvido no corredor; encaminhar sintom ticos respirat rios segundo o circuito da unidade; desinfectar balc o e canetas; n o reutilizar m scaras h midas.

h) Progn stico

A maioria dos infectados evolui para cura, sobretudo jovens sem comorbilidades e pessoas vacinadas. O progn stico agrava-se com idade avan ada, doen as cr nicas, gravidez de risco, imunodepress o, atraso na oxigena o e variantes mais virulentas. A letalidade global da pandemia foi muito desigual entre pa ses e vagas. Com a imunidade h brida (vacina + infec o) e as variantes micron, a letalidade desceu, mas a COVID-19 continua a matar pessoas vulner veis e a gerar long COVID. Uma em cada grupo de doentes graves pode ficar com sequelas respirat rias ou funcionais.

MEMORIZE PARA A PROVA

Cadeia para decorar: SARS-CoV-2 COVID-19 got culas/aeross is RT-PCR confirma leve/moderada/grave/cr tica oxig nio + suporte + preven o da trombose pior progn stico no idoso com comorbilidades. Anosmia/ageusia s o pistas cl ssicas das primeiras vagas. Antibi tico n o tratamento de rotina.

Papel do secret rio cl nico na COVID-19

Organizar filas e circuitos (respirat rio / n o respirat rio) definidos pela direc o.

Registar com exactid o identifica o, contactos e data de in cio dos sintomas.

N o divulgar listas de positivos .

Apoiar a estat stica di ria de casos, internamentos e bitos, com confidencialidade.

Informar o utente sobre documentos e hor rios n o sobre o resultado do vizinho .

VI. CULTURA GERAL

Cultura geral, neste concurso, sobretudo cultura geral angolana e institucional: geografia, hist ria, s mbolos, organiza o do Estado, sa de p blica e actualidade. Segue um comp ndio objectivo, no n vel esperado para Secret rio Cl nico.

1. Geografia f sica e humana

rea: cerca de 1 246 700 km€ (um dos maiores pa ses de frica).

Localiza o: frica Austral / Centro-Ocidental; costa atl ntica a oeste. Fronteiras: Rep blica do Congo e RD Congo a norte (Cabinda exclave entre os dois Congos), Z mbia a leste, Nam bia a sul.

Capital: Luanda (prov ncia e cidade). Sede da prov ncia de Luanda: munic pio da Ingombota, nos termos da nova DPA.

Relevo: orla litoral, planalto central (Huambo, Bi , Hu la), deserto do Namibe a sul-oeste. Ponto culminante cl ssico: Morro do Moco (Huambo), cerca de 2 620 m.

Rios principais: Kwanza, Cunene, Cubango, Cuando, Zambeze (leste), Zaire/Congo (fronteira norte), Dande, Catumbela.

Clima: tropical, com esta o das chuvas e esta o seca (cacimbo); rido no Namibe.

L ngua oficial: portugu s. L nguas nacionais de grande circula o: umbundo, kimbundu, kikongo, cokwe (tucokwe), nganguela, fiote, kwanyama, nhaneca, entre outras.

Moeda: kwanza (AOA).

Indicativo telef nico: +244.

Densidade m dia (Censo 2024): cerca de 29 hab./km€, com fort ssima concentra o no litoral e em Luanda.

2. S mbolos nacionais e datas c vicas

Bandeira: duas faixas horizontais (vermelho e negro) com engrenagem, estrela e machete amarelos ao centro.

Hino: Angola Avante .

Armas da Rep blica e ins gnia previstas na CRA.

11 de Novembro de 1975 Independ ncia Nacional.

4 de Fevereiro de 1961 in cio da luta armada de liberta o (assalto s cadeias de Luanda).

4 de Abril de 2002 Paz efectiva, ap s a morte de Jonas Savimbi (22 de Fevereiro de 2002) e o Memorando de Entendimento do Luena.

1 de Agosto Dia das For as Armadas Angolanas.

17 de Setembro Dia do Fundador da Na o e do Her i Nacional (nascimento de Ant nio Agostinho Neto, 1922).

25 de Maio Dia de frica.

1 de Maio Dia Internacional do Trabalhador.

25 de Dezembro / 4 de Janeiro festividades com express o nacional (consoante o calend rio oficial de feriados do ano).

3. Hist ria pol tica linha essencial

Reinos e Estados pr -coloniais: Kongo, Ndongo e Matamba (Njinga a Mbande), Lunda, Ovimbundu, entre outros.

Coloniza o portuguesa; Confer ncia de Berlim (1884 85) e ocupa o efectiva tardia do hinterland.

Movimentos de liberta o: MPLA, FNLA, UNITA.

Independ ncia: 11/11/1975. Primeiro Presidente: Ant nio Agostinho Neto (tamb m poeta Sagrada Esperan a).

Ap s Neto (1979): Jos Eduardo dos Santos (at 2017).

Guerra civil (1975 2002), com intervalos de acordos (Bicesse 1991, Lusaca 1994) e elei es de 1992.

Constitui o de 1975/1992 (sistema semi-presidencialista) substitu da pela Constitui o de 2010 (sistema presidencialista de matriz pr pria: o Presidente o Titular do Poder Executivo, eleito como cabe a de lista do partido mais votado). Primeira revis o: Lei n. 18/21.

Presidente actual: Jo o Manuel Gon alves Louren o (desde 2017; reeleito em 2022).

Assembleia Nacional: rg o legislativo unicameral.

Poder judicial: Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunal de Contas, Supremo Tribunal Militar, tribunais comuns.

4. Organiza o do Estado (para cultura geral de prova)

Angola uma Rep blica soberana e independente, Estado de Direito Democr tico, unit rio, com descentraliza o e desconcentra o. rg os de soberania previstos na CRA incluem o Presidente da Rep blica, a Assembleia Nacional e os Tribunais. O Poder Executivo exercido pelo Presidente, coadjuvado pelo Vice-Presidente e pelos Ministros de Estado e Ministros. N o h Primeiro-Ministro no desenho da CRA de 2010 (havia-o na ordem constitucional anterior).

5. Economia e inser o internacional

Economia fortemente dependente do petr leo e dos diamantes; esfor os de diversifica o (agricultura, pescas, minerais, turismo, ind stria ligeira).

Membro da ONU, Uni o Africana, SADC, CPLP, OPEP (regresso/participa o no quadro petrol fero internacional), CIMEIRA frica-Am rica do Sul e outros foros.

Parceiros tradicionais: Portugal, China, Brasil, EUA, pa ses da SADC e da UE.

OGE Or amento Geral do Estado: instrumento anual de pol tica econ mica.

6. Sistema de sa de o essencial para o candidato do MINSA

O direito sa de est consagrado na CRA. O Estado promove o acesso universal e equitativo.

SNS rede p blica de prestadores, organizada por n veis: prim rio (postos e centros de sa de, munic pios), secund rio (hospitais gerais / municipais e provinciais) e terci rio (hospitais nacionais e especializados).

Programas priorit rios cl ssicos: vacina o (PAV), sa de materno-infantil, paludismo, VIH/SIDA, tuberculose, doen as n o transmiss veis, gua e saneamento, nutri o.

Paludismo continua a ser uma das principais causas de morbimortalidade.

Documentos de planeamento: Plano Nacional de Desenvolvimento (PND 2023 2027) e instrumentos sanit rios nacionais (PNDS e suced neos).

O secret rio cl nico pe a do n vel de presta o: sem arquivo e sem acolhimento, o direito sa de falha na pr tica.

7. Personalidades e cultura

Agostinho Neto, Jos Eduardo dos Santos, Jo o Louren o chefes de Estado.

Njinga a Mbande resist ncia dos s culos XVII.

Pepetela, Luandino Vieira, Ondjaki, Ana Paula Tavares, Jos Eduardo Agualusa letras.

V rias express es musicais: semba, kizomba, kuduro; figuras como Ngola Ritmos, Bonga, Waldemar Bastos.

Patrim nio: Cidade Velha de Mbanza Kongo (Patrim nio Mundial da UNESCO).

8. Mini-perguntas de cultura (treino r pido)

16. A independ ncia de Angola foi proclamada em:

A) 4 de Fevereiro de 1961

B) 11 de Novembro de 1975

C) 4 de Abril de 2002

D) 5 de Fevereiro de 2010

E) 11 de Novembro de 1974

17. O hino nacional de Angola :

A) A Portuguesa

B) Nkosi Sikelel' iAfrika

C) Angola Avante

D) Sagrada Esperan a

E) Independ ncia Total

18. Mbanza Kongo, Patrim nio da UNESCO, situa-se na prov ncia de:

A) U ge

B) Bengo

C) Cabinda

D) Zaire

E) Malange

MEMORIZE PARA A PROVA

Datas de ouro: 4/02/1961 luta armada; 11/11/1975 independ ncia; 4/04/2002 paz; 2010 Constitui o vigente; 2017 Jo o Louren o; 2024/2025 Censo definitivo e nova DPA em vigor.

VII. DIVIS O POL TICO-ADMINISTRATIVA DE ANGOLA (2024)

a) Prov ncias, munic pios e comunas

A Rep blica de Angola organiza o territ rio em prov ncias, estas em munic pios e estes em comunas (podendo existir ainda outras figuras de organiza o urbana, conforme a lei). Com a reforma da DPA aprovada em 2024 e entrada em vigor em 1 de Janeiro de 2025, o pa s passou a ter:

MEMORIZE PARA A PROVA

N meros oficiais da nova DPA: 21 prov ncias, 326 munic pios e 378 comunas. Antes: 18 prov ncias e 164 munic pios. Diploma de refer ncia: Lei n. 14/24, de 5 de Setembro, sobre a divis o pol tico-administrativa. Superf cie nacional: cerca de 1 246 700 km€.

Cada prov ncia dirigida por um Governador Provincial (nomeado no quadro do Poder Executivo). O munic pio dirigido pela Administra o Municipal. A comuna a unidade de maior proximidade em muita da rea rural. A implementa o da DPA extinguiu a figura dos distritos urbanos como escal o aut nomo, mantendo munic pios e comunas (algumas comunas org nicas).

Quadro das 21 prov ncias (sede, popula o do Censo 2024 e origem)

Prov ncia	Sede	Pop. 2024	Nota DPA
Bengo	Dande (Caxito)	716 335	Mantida
Benguela	Benguela	2 597 638	Mantida
Bi	Cuito	2 264 874	Mantida
Cabinda	Cabinda	903 370	Mantida (exclave)
Cuando	Mavinga	138 770	NOVA (ex-Cuando Cubango)
Cuanza Norte	Cazengo (N'dalatando)	659 097	Mantida
Cuanza Sul	Sumbe	2 327 981	Mantida
Cubango	Menongue	570 447	NOVA designa o (ex-Cuando Cubango)
Cunene	Cuanhama (Ondjiva)	1 806 417	Mantida
Huambo	Huambo	2 691 902	Mantida
Hu la	Lubango	3 302 866	Mantida
Icolo e Bengo	Catete	1 372 670	NOVA (ex-Luanda)
Luanda	Luanda (Ingombota)	8 816 297	Redesenhada
Lunda Norte	Dundo	1 742 217	Mantida
Lunda Sul	Saurimo	893 936	Mantida
Malanje	Malanje	1 298 250	Mantida
Moxico	Luena	574 253	Redesenhada
Moxico Leste	Cazombo	411 074	NOVA (ex-Moxico)
Namibe	Mo medes	815 708	Mantida
U ge	U ge	2 017 921	Mantida
Zaire	Mbanza Kongo	682 658	Mantida

Quadro 6 21 prov ncias, sedes e popula o residente (INE, Resultados Definitivos do RGPH 2024). Totais oficiais: 36 604 681 habitantes.

A soma das popula es do Quadro 6 reproduz o total nacional. Luanda concentra 24,1% dos residentes. Seguem-se Hu la (9,0%), Huambo (7,4%), Benguela (7,1%), Cuanza Sul (6,4%) e Bi (6,2%): estas

prov ncias, com Luanda, concentram cerca de 60% da popula o. A menos populosa o Cuando (138 770; 0,4%).

b) Cria o de novas prov ncias e munic pios

A Assembleia Nacional aprovou em Agosto de 2024 a nova divis o; a lei foi promulgada e publicada como Lei n. 14/24, de 5 de Setembro. Objectivos declarados: adequar o mapa ao crescimento demogr fico e das infra-estruturas; aproximar servi os e centros de decis o dos cidad os; clarificar limites; reduzir assimetrias; promover o desenvolvimento harmonioso.

Tr s novas prov ncias

Nova prov ncia	Origem	Sede	Pop. 2024	Nota
Icolo e Bengo	Prov ncia de Luanda	Catete	1 372 670	Desanexa o da coroa periurbana / hist rica de Luanda (colo e Bengo).
Cuando	Cuando Cubango	Mavinga	138 770	Parte leste/sudeste do antigo Cuando Cubango.
Moxico Leste	Moxico	Cazombo	411 074	Leste do Moxico (alto Zambeze). Em debates iniciais surgiu a designa o Cassai Zambeze .

Quadro 7 As tr s prov ncias criadas na reforma de 2024/2025.

O antigo Cuando Cubango deu origem a Cuando (sede Mavinga) e Cubango (sede Menongue). O aumento de munic pios (de 164 para 326) resultou sobretudo da eleva o de comunas e distritos a munic pio (+162). A m dia projectada da ordem de 15 munic pios e 18 comunas por prov ncia, embora a distribui o real n o seja uniforme (Malanje e U ge, por exemplo, t m malha mais densa).

ATEN O

Na prova, n o use o mapa de 18 prov ncias. Cuando Cubango deixou de ser uma nica prov ncia. N o escreva Icole a grafia oficial corrente Icolo e Bengo (tamb m surge colo e Bengo). A sede Catete, n o Viana nem Cacuaco. A sede do Cuando Mavinga, n o Menongue.

c) Impacto da divis o administrativa na gest o dos servi os de sa de

Para o MINSA e para o secret rio cl nico, a DPA n o um mapa de geografia: uma mudan a da arquitectura de gest o.

Aproxima o dos servi os. Mais munic pios significam mais administra es e, potencialmente, mais unidades de refer ncia municipal, postos de recolha estat stica e pontos de atendimento. O cidad o deixa de percorrer dezenas de quil metros para um acto administrativo de sa de.

Novos Gabinetes Provinciais de Sa de. Icolo e Bengo, Cuando e Moxico Leste precisam de estrutura sanit ria pr pria: direc o, dep sito de medicamentos, cadeia de frio, vigil ncia epidemiol gica e recursos humanos. O concurso de ingresso externo responde, em parte, a esse d fice.

Redistribui o de recursos humanos e do OGE. O Or amento passa a dotar 21 prov ncias. Hospitais que eram do interior de Luanda podem passar tutela de Icolo e Bengo; o mesmo no leste do Moxico e no Cuando.

Sistemas de informa o. Mapas estat sticos, c digos geogr ficos (geoc digos do INE), refer ncia e contra-refer ncia, e o ficheiro do utente t m de ser actualizados. Um processo cl nico de Luanda pode ter de ser reclassificado territorialmente.

Vigil ncia epidemiol gica e campanhas. Paludismo, sarampo, c lera e vacina o organizam-se por territ rio. Fronteiras novas exigem coordena o para n o criar zonas cinzentas sem responsabilidade clara.

Equidade. A DPA pretende reduzir assimetrias. Sem profissionais, medicamentos e transporte, o novo munic pio s um nome. Da a relev ncia do concurso p blico e da lota o nas prov ncias com maior d fice.

Risco de transi o. Duplica o de arquivos, perda de s ries estat sticas, d vidas sobre a tutela de unidades e atraso na instala o de servi os. O secret rio cl nico deve perguntar, por escrito se preciso,

qual a tutela actual da unidade e manter o arquivo ntegro durante a transi o.

DICA DE PROVA

Pergunta t pica: Qual a sede de Icolo e Bengo? Catete. Quantos munic pios tem Angola ap s a Lei n. 14/24? 326. Que impacto tem a DPA na sa de? aproxima o dos servi os, novos GPS, redistribui o de RH e do OGE, actualiza o dos sistemas de informa o, risco de vazios na transi o.

VIII. CENSO POPULACIONAL DE ANGOLA 2024

O Recenseamento Geral da Popula o e Habita o (RGPH) 2024 foi realizado pelo Instituto Nacional de Estat stica (INE), dez anos ap s o Censo de 2014. Os resultados definitivos foram divulgados em 2025. a fonte oficial da popula o residente e da habita o.

a) Objectivos do Censo Geral da Popula o e Habita o

Um censo a opera o estat stica que visa contar, no mesmo per odo de refer ncia, todas as pessoas residentes e caracterizar os alojamentos. Objectivos principais:

Determinar o volume, a estrutura (sexo, idade) e a distribui o territorial da popula o.

Caracterizar os agregados familiares e as condi es de habita o.

Produzir a base de amostragem para inqu ritos posteriores (IIMS, IDR, emprego, etc.).

Actualizar indicadores para o PND, o OGE, os ODS e as pol ticas sectoriais (sa de, educa o, gua, energia, protec o social).

Apoiar o recorte eleitoral, o planeamento urbano e a DPA.

Medir o crescimento intercensit rio e as migra es internas (urbano/rural, litoral/interior).

Conhecer o acesso a documentos (registo de nascimento, BI), educa o, gua, saneamento e energia.

Princ pios cl ssicos de um censo: universalidade (todos), simultaneidade (mesmo momento de refer ncia), individualidade (cada pessoa registada) e periodicidade (em regra, de 10 em 10 anos). O recenseador visita o alojamento; a participa o um dever c vico e a informa o individual confidencial.

b) Principais indicadores demogr ficos

Indicador (INE / RGPH 2024)	Valor oficial
Popula o residente 2024	36 604 681
Popula o 2014	25 789 024
Acr scimo intercensit rio	• 10,8 milh es (+42% em 10 anos)
Taxa de crescimento m dio anual	3,5%
Homens	17 931 985 (49%)
Mulheres	18 672 696 (51%)
ndice de masculinidade	96 homens / 100 mulheres (era 94 em 2014)
Idade m dia	23,2 anos (era 20,6 em 2014)
Popula o 0 14 anos	46,3% (ligeira descida face a 2014)
rea urbana	23 991 388 (65,5%)
rea rural	12 613 293 (34,5%)
Luanda (peso nacional)	8 816 297 (24,1%)
Densidade m dia	• 29 hab./km€
Tamanho m dio do agregado	3,9 pessoas (era 4,6 em 2014)
Alfabetismo (15+ anos)	72,6% (era 65,6%)
Alfabetismo 15 24 anos	74,9%
Nunca frequentou a escola (5+ anos)	24,2%
A frequentar a escola (5+ anos)	41,1%
Taxa l quida no ensino prim rio (6 11)	62,1% (era 74,8% em 2014)
Taxa l quida no secund rio (12 18)	41,9%
Registo de nascimento (total)	63,0% (era 53,5%)

Indicador (INE / RGPH 2024)	Valor oficial
Registo de nascimento (0 4 anos)	39,2% (era 24,8%)
Popula o 5+ com BI	52,4%
gua apropriada para beber (agregados)	56,0%

Quadro 8 Indicadores-chave do Censo 2024 (resultados definitivos / relat rio-s ntese do INE).

Leitura til: Angola continua a ser um pa s muito jovem e em r pido crescimento, cada vez mais urbano, com mais mulheres do que homens, e com progressos no registo civil e no alfabetismo dos adultos. Persistam desigualdades urbano-rurais gritantes: o registo de nascimento cerca de 75,5% no urbano e apenas 24,5% no rural; o BI cobre 63% no urbano e 30,9% no rural.

c) Utilidade dos dados censit rios para pol ticas p blicas de sa de

Sem denominador populacional fi vel n o h planeamento sanit rio s rio. O Censo serve para:

Dimensionar a rede quantos postos, centros, maternidades e camas por munic pio, luz da popula o real e n o de estimativas velhas.

Calcular taxas mortalidade, incid ncia, cobertura vacinal, partos institucionais: o numerador vem da estat stica de sa de; o denominador vem do censo (ou das suas projec es).

Alocar recursos humanos r cios de m dicos, enfermeiros e pessoal de apoio (incluindo secret rios cl nicos) por 10 000 habitantes.

Programas materno-infantis o peso dos 0 14 anos (46,3%) imp e prioridade a PAV, nutri o, escolas e pediatria.

Doen as cr nicas e geriatria o ligeiro aumento da idade m dia antecipa mais hipertens o, diabetes e cancro nas pr ximas d cadas.

Urbaniza o e sa de ambiental 65,5% urbanos: paludismo urbano, c lera, res duos, ar, acidentes de via o, sa de mental.

Iniquidades cruzar territ rio, sexo e condi es de habita o (gua 56%) para dirigir campanhas s comunas esquecidas.

Registo civil e sa de 39,2% das crian as 0 4 com registo: sem certid o, h barreiras ao cart o de vacinas, escola e protec o social. O hospital deve articular-se com o registo de nascimentos.

Emerg ncias estimativas de popula o para vacina o em massa, c lera ou COVID-19.

Base de amostragem do IIMS o inqu rito de sa de assenta na malha do censo.

d) Crescimento populacional e distribui o geogr fica

Entre 2014 e 2024 Angola ganhou cerca de 10,8 milh es de habitantes (taxa m dia anual de 3,5%), um dos crescimentos mais r pidos do mundo. A transi o demogr fica est no in cio: a fecundidade desce (ver IIMS), mas a estrutura ainda piramidal e o crescimento natural permanece alto.

A distribui o muito desigual:

O litoral e o planalto central concentram a maior parte da popula o (Luanda, Hu la, Huambo, Benguela, Cuanza Sul, Bi).

O leste e o extremo sudeste s o vastos e pouco povoados (Cuando, Moxico Leste, Cubango, Moxico).

Cerca de 24% da popula o vive nos dez munic pios mais populosos (Kilamba Kiaxi, Cacuaco, Lubango, Viana, Huambo, Cazenga, Maianga, Camama, entre outros), numa frac o m nima do territ rio.

Icolo e Bengo, com 1,37 milh es de habitantes, nasce j como prov ncia de peso interm dio, o que pressiona de imediato a rede de sa de periurbana de Luanda.

A descida do tamanho do agregado (4,6 3,9) sugere mudan as nos arranjos familiares urbanos.

FUNDAMENTO LEGAL

Produtor oficial: INE. Documentos de estudo: Relat rio dos Resultados Definitivos do RGPH 2024 e Relat rio-S ntese. Na prova, privilegie sempre o n mero do INE (36 604 681) e n o estimativas extra-oficiais da ONU ou da imprensa.

IX. INQU RITO DE INDICADORES M LTIPLOS E DE SA DE (IIMS 2023 2024)

O IIMS o grande inqu rito amostral de sa de e demografia de Angola. A edi o 2023 2024 a segunda (a primeira foi 2015 2016). Foi realizado pelo INE em colabora o com o MINSA, com assist ncia t cnica do programa DHS (ICF) e do UNICEF, inserindo-se no 8. ciclo DHS e no 6. ciclo MICS. Trabalho de campo: Setembro de 2023 a Janeiro de 2024 (cerca de seis meses; dezenas de equipas no territ rio). Resultados apresentados em 2025.

a) Objectivos do IIMS

Disponibilizar indicadores sociodemogr ficos e de sa de actualizados e compar veis internacionalmente.

Conhecer n veis e tend ncias da fecundidade e da mortalidade infantil, infanto-juvenil e materna, e os seus determinantes.

Medir conhecimento e uso de contracep o e a necessidade insatisfeita de planeamento familiar.

Recolher dados de sa de materna: pr -natal, parto, p s-parto, aleitamento.

Avaliar imuniza o, nutri o, IRA, diarreia, febre e desenvolvimento da primeira inf ncia.

Produzir informa o sobre VIH/SIDA (conhecimentos, testagem, estigma) e outras IST.

Caracterizar gua, saneamento, higiene, paludismo (mosquiteiros), viol ncia dom stica e mortalidade adulta.

Apoiar a monitoriza o dos ODS, do PND 2023 2027 e do planeamento sanit rio nacional.

Fornecer desagrega o por prov ncia, rea de resid ncia, sexo, escolaridade e quintil de riqueza essencial para a equidade.

DICA DE PROVA

Censo conta toda a popula o (universo). IIMS entrevista uma amostra representativa, com question rios longos de sa de. O Censo d o denominador e o retrato habitacional; o IIMS d a profundidade sanit ria. Ambos se complementam.

b) Indicadores de sa de materno-infantil

Indicador	IIMS 2023 2024	Nota / tend ncia
Taxa de mortalidade neonatal	16 / 1 000 nados-vivos	24 16
Taxa de mortalidade infantil (< 1 ano)	32 / 1 000	44 32
Taxa de mortalidade infanto-juvenil (< 5 anos)	52 / 1 000	68 52
Leitura do INE / estudo	1 em cada 19 crian as n o chega aos 5 anos	Melhoria, ainda grave
Raz o de mortalidade materna	170 / 100 000 nados-vivos	Indicador ODS 3.1.1
Partos assistidos por profissional qualificado	49,8%	Ainda metade sem assist ncia qualificada
Consultas pr -natais por profissional qualificado	• 77%	Desceu face a • 81% em 2015 16
Fecundidade (TGF)	cerca de 5,5 filhos/mulher (tend ncia decrescente)	Era mais alta em 2015 16

Quadro 9 Sa de materno-infantil (relat rio preliminar/final IIMS e comunica es oficiais do INE).

A descida da mortalidade infantil o principal xito sanit rio da d cada. Por m, menos de metade dos partos tem profissional qualificado e o pr -natal qualificado recuou alguns pontos sinal de tens o na rede de cuidados prim rios, sobretudo no rural.

c) Nutri o, vacina o e mortalidade

Nutri o (menores de 5 anos)

Indicador nutricional	Valor	Leitura
Desnutri o cr nica (baixa altura/idade)	40%	38% 40% (piorou)
Desnutri o cr nica rural / urbana	51% / 31%	Forte iniquidade
Piores prov ncias (cr nica)	Bi 56%; Cuanza Sul 53%; U ge 48%; Huambo e Hu la 47%	Luanda a mais baixa (24%)
Baixo peso	21%	19% 21% (piorou)
Desnutri o aguda (emacia o)	5%	Est vel
Aleitamento materno exclusivo (< 6 meses)	cerca de 38%	Ainda longe da meta OMS (50 70%)

Quadro 10 Nutri o infantil no IIMS 2023 2024.

Vacina o

A cobertura mant m-se baixa e desigual. S nteses do inqu rito apontam, entre crian as eleg veis:

Apenas cerca de 29% das crian as de 12 23 meses receberam todos os antig nios b sicos (com varia es provinciais extremas: valores muito baixos no Moxico em fichas regionais).

DPT 3., dose na ordem dos 41% (s ntese de quadros do relat rio).

Sarampo-rub ola 2., dose na ordem dos 33%.

Vacina pneumoc cica (ltima dose do programa) na ordem dos 36%.

A quebra da cobertura explica surtos de sarampo e a persist ncia da mortalidade evit vel.

Mortalidade o que decorar

Tr s n meros em cascata: 16 32 52 (neonatal, infantil, infanto-juvenil, por 1 000). Materna: 170 por 100 000. A melhoria da sobreviv ncia infantil convive com o agravamento da desnutri o cr nica: as crian as morrem menos, mas muitas crescem mal (stunting), o que comprometer escola, trabalho e sa de de adultos.

d) Uso dos dados do IIMS no planeamento sanit rio

Prioriza o geogr fica. Concentrar recursos de nutri o no Bi , Cuanza Sul, U ge, Huambo e Hu la; refor ar partos qualificados no rural; n o desinvestir Luanda (volume absoluto enorme).

PAV. Redesenhar microplanos de vacina o onde a cobertura de antig nios b sicos inferior a 1/3.

Rede materna. Se s 49,8% dos partos s o qualificados, faltam salas de parto, ambul ncias, enfermeiros de sa de materna e casas de espera.

Comunica o e extens o. Aleitamento a 38% e pr -natal em recuo exigem agentes de desenvolvimento comunit rio e secretarias organizadas nas consultas de crian a s e de pr -natal.

Monitoriza o do PND e dos ODS (3.1 mortalidade materna, 3.2 infantil, 2.2 malnutri o, 3.7 sa de sexual e reprodutiva).

Forma o e lota o. Os dados justificam concursos e a coloca o de pessoal de apoio (secret rios, estat sticos, maqueiros) nas unidades que alimentam o sistema de informa o.

Na secretaria cl nica. O IIMS n o se preenche no balc o , mas a qualidade do Boletim de Sa de Infantil, do partograma, do registo de vacinas e da ficha de bito o que permite, mais tarde, inqu ritos e estat sticas cred veis. Um cart o de vacinas mal preenchido enviesa a cobertura.

MEMORIZE PARA A PROVA

Trio Censo / IIMS / DPA: o Censo diz quantos somos e onde estamos; o IIMS diz de que adoecemos, morremos e como usamos os servi os; a DPA diz quem gere cada peda o do mapa. Uma resposta de prova de excel ncia articula os tr s.

X. INTELIG NCIA ARTIFICIAL (IA)

a) Conceito de Intelig ncia Artificial

Intelig ncia Artificial o campo da inform tica que desenvolve sistemas capazes de executar tarefas que, se realizadas por humanos, exigiriam intelig ncia: perceber linguagem, reconhecer imagens, aprender com dados, raciocinar, decidir ou recomendar. N o um c rebro electr nico consciente . , na pr tica, matem tica + dados + poder de c lculo.

Distin es teis em prova:

IA estreita (ANI) a que existe hoje: faz bem uma fam lia de tarefas (traduzir, classificar uma radiografia, sugerir texto).

IA geral (AGI) hip tese futura de compet ncia ampla, semelhante humana; n o est dispon vel.

Aprendizagem autom tica (machine learning) o sistema aprende padr es a partir de exemplos, sem ser explicitamente programado para cada regra.

Aprendizagem profunda (deep learning) redes neuronais artificiais com muitas camadas; base da vis o computacional e dos grandes modelos de linguagem.

IA generativa produz texto, imagem, udio ou c digo novos (ex.: modelos de linguagem de grande escala).

Algoritmo sequ ncia finita de instru es; na IA, muitas vezes treinado e n o apenas escrito m o.

Dado pessoal / dado de sa de qualquer informa o que identifique o doente (nome, BI, prontu rio, voz, face, genoma).

b) Aplica es da IA na sa de

Dom nio	Exemplo concreto
Diagn stico auxiliado	Leitura de raio-X, TC, retinografia, pele; alerta de tuberculose ou COVID em imagem.
Triagem e filas	Sistemas que priorizam urg ncias com base em sintomas registados na recep o.
Processo cl nico electr nico	Codifica o autom tica de diagn sticos, sum rios de alta, detec o de alergias.
Secretariado cl nico	Agendamento inteligente, redu o de faltas (SMS preditivo), transcri o de voz, atendimento inicial por chatbot institucional.
Gest o hospitalar	Previs o de ocupa o de camas, stocks de medicamentos e de oxig nio, escalas de pessoal.
Sa de p blica	Modelos de surto (c lera, paludismo, sarampo), an lise de redes sociais para rumores, apoio ao PAV.
Investiga o e forma o	Descoberta de f rmacos, simula o, tutoria para profissionais.
Acessibilidade	Tradu o portugu s l nguas nacionais, leitura em voz alta para analfabetos, apoio a deficientes visuais.

Quadro 11 Aplica es da IA com relev ncia para o SNS e para a secretaria.

c) Benef cios e riscos da IA no sector p blico

Benef cios

Ganho de tempo em tarefas repetitivas (marca o, arquivo, relat rios).

Apoio decis o cl nica e administrativa em contextos com poucos especialistas.

Poss vel redu o de erros de transcri o e de extravio.

Melhor planeamento (prever picos de paludismo ou de partos).

Amplia o do acesso a informa o em portugu s simples.

Transpar ncia potencial: rasto digital de quem acedeu ao processo.

Riscos

Enviesamento (bias) se o sistema foi treinado com dados de outro pa s ou s de Luanda, pode falhar no Cuando ou em crian as desnutridas.

Alucina o a IA generativa inventa refer ncias, doses ou leis com tom convincente.

Opacidade caixa negra : dif cil explicar ao utente por que foi recusada uma vaga.

Desqualifica o profissional o funcion rio deixa de verificar e assina o que a m quina escreveu.

Exclus o digital idosos, rurais e analfabetos ficam de fora se o nico canal for uma aplica o.

Ciberseguran a e fuga de dados um hospital alvo valioso; um USB ou um grupo de WhatsApp bastam para vazar mil processos.

Depend ncia de fornecedores software estrangeiro, custos, perda de soberania sobre dados de sa de da Na o.

Vigil ncia e abuso uso de reconhecimento facial ou de dados de sa de para fins alheios ao cuidado.

Responsabilidade quem responde se o algoritmo errar: o m dico, o secret rio, o MINSA ou a empresa?

d) tica e protec o de dados

Princ pios ticos de refer ncia (UNESCO, OMS e boa pr tica de administra o):

Dignidade humana e autonomia a m quina auxilia; n o substitui o consentimento do doente nem a responsabilidade do profissional.

Benefic ncia e n o-malefic ncia s implantar sistemas que comprovadamente ajudem e n o prejudiquem.

Justi a e n o discrimina o testar o sistema nas 21 prov ncias e nos grupos vulner veis.

Transpar ncia e explicabilidade o utente deve saber que est a falar com um sistema autom tico.

Responsabilidade e auditoria rasto de decis es; supervis o humana obrigat ria em actos que afectem direitos.

Privacidade e minimiza o recolher s os dados necess rios, pelo tempo necess rio, com acesso restrito.

Seguran a e robustez copias de seguran a, palavras-passe, actualiza es, forma o.

Soberania e interesse p blico dados de sa de angolanos s o patrim nio sens vel; contratos devem impedir o treino livre de modelos comerciais com prontu rios do SNS.

FUNDAMENTO LEGAL

Em Angola, o dever de proteger dados pessoais dos cidad os est expresso na Lei n. 26/22, art. 7. , al nea b), e na legisla o espec fica de protec o de dados (refer ncia cl ssica: Lei n. 22/11, de 17 de Junho Protec o de Dados Pessoais), al m do sigilo profissional e da Pauta Deontol gica (reserva e discri o). Dados de sa de s o dados sens veis: exigem base legal, finalidade clara e medidas de seguran a refor adas.

Regras pr ticas para o secret rio cl nico (decore e aplique)

N o colar dados de doentes em ChatGPT, WhatsApp ou e-mail pessoal para redigir mais depressa .

N o fotografar o ecr do processo cl nico.

Bloquear o computador ao ausentar-se do balc o.

N o partilhar senhas; n o usar a mesma senha do Facebook no sistema hospitalar.

Confirmar a identidade de quem pede informa es (o primo no telefone pode n o o ser).

Se a institui o adoptar um chatbot, o cidad o deve poder falar com um humano.

Qualquer ferramenta de IA deve ser autorizada pela direc o e cumprir o regulamento interno.

Erros da m quina s o erros do servi o se ningu m os validar o dever de zelo mant m-se.

ATEN O

A IA n o revoga a Pauta Deontol gica. Imparcialidade, sigilo, parcim nia e legalidade aplicam-se ao algoritmo como ao funcion rio. Um sistema que marca consultas primeiro para quem paga g sosa digital improbidade automatizada.

BATERIA DE QUEST ES TIPO PROVA

Simulado misto de 40 itens, no estilo de escolha m ltipla. Tempo sugerido: 70 minutos. N o consulte o manual. A chave comentada est no cap tulo seguinte. As quest es 1 7 (verbal) e 8 18 (num rico/cultura j apresentadas) continuam a contar; abaixo seguem itens novos, numerados a partir de 19, cobrindo todo o programa.

19. A Administra o P blica angolana, nos termos do art. 198. -A da CRA, integra:

A) Apenas os minist rios sediados em Luanda.

B) Somente a Administra o Directa do Estado.

C) A Administra o Directa e Indirecta do Estado, a Aut noma e a Independente.

D) Os partidos pol ticos e as igrejas.

E) Apenas os governos provinciais.

20. Desconcentra o administrativa significa, em s ntese:

A) Criar um Estado federal.

B) Repartir compet ncias por rg os do pr prio Estado, mantendo a unidade da pessoa colectiva.

C) Privatizar hospitais.

D) Transferir soberania para a Uni o Africana.

E) Extinguir munic pios.

21. A Lei de Bases da Fun o P blica em vigor a:

A) Lei n. 17/90, de 20 de Outubro.

B) Lei n. 26/22, de 22 de Agosto.

C) Lei n. 14/24, de 5 de Setembro.

D) Resolu o n. 27/94, de 26 de Agosto.

E) Lei n. 3/10, de 29 de Mar o.

22. A nomea o, na Lei n. 26/22:

A) proibida no sector da sa de.

B) a regra de ingresso na Fun o P blica.

C) Substituiu definitivamente o concurso p blico.

D) Aplica-se s a ministros.

E) sin nimo de contrato de trabalho p blico.

23. A Pauta Deontol gica do Servi o P blico foi aprovada pela:

A) Lei n. 26/22.

B) Constitui o de 2010.

C) Resolu o n. 27/94, de 26 de Agosto.

D) Lei n. 14/24.

E) Decreto presidencial do MINSA de 2026.

24. Aceitar dinheiro de um utente para antecipar uma consulta fere, em primeiro lugar, o dever de:

A) Pontualidade.

B) Assiduidade.

C) Probidade.

D) Autoforma o.

E) Motiva o do acto administrativo.

25. Comentar o diagn stico de um doente num candongueiro viola sobretudo:

A) O dever de parcim nia.

B) O dever de discri o / protec o de dados e o sigilo.

C) O dever de respeito aos s mbolos nacionais.

D) O princ pio da desconcentra o.

E) O direito greve.

26. N o existe dever de obedi ncia quando a ordem do superior:

A) verbal e n o escrita.

B) dada depois das 15 horas.

C) Implica a pr tica de um crime.

D) Desagrada politicamente ao funcion rio.

E) Aumenta o volume de trabalho.

27. O agente etiol gico da COVID-19 :

A) O v rus da gripe A (H1N1).

B) O bacilo de Koch.

C) O SARS-CoV-2.

D) O VIH-1.

E) O Plasmodium falciparum.

28. O teste considerado padr o de refer ncia para confirmar a infec o aguda por SARS-CoV-2 :

A) A serologia IgG isolada.

B) A radiografia dos seios perinasais.

C) O RT-PCR em amostra respirat ria.

D) A glicemia em jejum.

E) O teste cut neo de Mantoux.

29. Anosmia e ageusia, no contexto da COVID-19, designam:

A) Febre e tosse.

B) Perda de olfacto e de paladar.

C) Diarreia e v mitos.

D) Icter cia e prurido.

E) Incontin ncia e reten o urin ria.

30. Ap s a Lei n. 14/24, Angola passou a ter:

A) 18 prov ncias e 164 munic pios.

B) 20 prov ncias e 200 munic pios.

C) 21 prov ncias, 326 munic pios e 378 comunas.

D) 21 prov ncias e 164 munic pios.

E) 24 prov ncias e 378 munic pios.

31. A sede da prov ncia de Icolo e Bengo :

A) Viana

B) Cacuaco

C) Catete

D) Caxito

E) Dande

32. A prov ncia do Cuando tem sede em:

A) Menongue

B) Mavinga

C) Cuito Cuanavale

D) Luena

E) Cazombo

33. A nova prov ncia que resulta da divis o do Moxico :

A) Lunda Sul

B) Cubango

C) Moxico Leste

D) Icolo e Bengo

E) Cuando

34. Segundo os resultados definitivos do Censo 2024, a popula o residente de Angola de:

A) 25 789 024 habitantes.

B) 30 000 000 habitantes.

C) 36 604 681 habitantes.

D) 40 112 008 habitantes.

E) 8 816 297 habitantes.

35. A taxa de crescimento m dio anual intercensit ria 2014 2024 anunciada pelo INE de:

A) 1,1%

B) 2,0%

C) 3,5%

D) 5,2%

E) 10,8%

36. No Censo 2024, a popula o urbana representa cerca de:

A) 34,5%

B) 46,3%

C) 51%

D) 65,5%

E) 90%

37. A prov ncia mais populosa e a menos populosa, respectivamente, s o:

A) Hu la e Namibe

B) Luanda e Cuando

C) Luanda e Cabinda

D) Huambo e Moxico Leste

E) Benguela e Bengo

38. No IIMS 2023 2024, a taxa de mortalidade infantil de:

A) 16 por 1 000 nados-vivos

B) 32 por 1 000 nados-vivos

C) 52 por 1 000 nados-vivos

D) 170 por 1 000 nados-vivos

E) 40 por 1 000 nados-vivos

39. A desnutri o cr nica em menores de 5 anos, no IIMS 2023 2024, situa-se em cerca de:

A) 5%

B) 21%

C) 32%

D) 40%

E) 70%

40. A percentagem de partos assistidos por profissional de sa de qualificado, no IIMS 2023 2024, de aproximadamente:

A) 19,8%

B) 29%

C) 49,8%

D) 77%

E) 90%

41. O IIMS distingue-se do Censo porque:

A) Substitui o Censo de dez em dez anos.

B) um inqu rito por amostra, focado em indicadores de sa de e demografia.

C) Conta todos os alojamentos do pa s.

D) realizado exclusivamente pelo MINSA, sem o INE.

E) S cobre Luanda.

42. Um benef cio t pico da IA na secretaria cl nica :

A) Eliminar o dever de sigilo.

B) Substituir o consentimento do doente.

C) Apoiar o agendamento e reduzir tarefas repetitivas, sob supervis o humana.

D) Publicar automaticamente os diagn sticos na internet.

E) Dispensar a urbanidade no atendimento.

43. Colar o processo cl nico num servi o p blico de IA generativa, sem autoriza o, viola principalmente:

A) O dever de pontualidade.

B) A protec o de dados pessoais e o sigilo.

C) O hino nacional.

D) A regra de tr s simples.

E) O princ pio da publicidade absoluta.

44. Angola Avante :

A) O lema da CPLP.

B) O hino nacional.

C) A moeda nacional.

D) O nome da Constitui o de 2010.

E) A sede do MINSA.

45. O direito dos administrados a serem ouvidos e informados pela Administra o consta, na CRA, do artigo:

A) 1.

B) 21.

C) 198. -A

D) 200.

E) 226.

Itens 1 18 (cap tulos III, IV e VI) tamb m integram o treino. Some 45 itens no total deste livro.

FOLHA DE RESPOSTAS E CHAVE COMENTADA

N.	Chave	Coment rio m nimo
1	B	O texto liga prazos e urbanidade; A, C, D e E contradizem-no.
2	C	O processo da institui o / do doente, n o bem particular de quem escreve.
3	B	Rela o de ant nimos legais/ ticos.
4	C	Igualdade de tratamento = imparcialidade.
5	C	Diagn stico identifica; progn stico prev evolu o.
6	C	Salvo = excepto.
7	B	Pauta = norma de deveres ticos.
8	C	0,30 450 = 135.
9	D	200 70 + 40 = 170 (35% de 200 = 70).
10	C	O dobro de pessoas em metade do tempo = mesmo n mero (400).
11	C	(18+22+25+19+26)/5 = 110/5 = 22.
12	C	(52 40)/40 = 12/40 = 30%.
13	B	70% de 40 = 28 ocupadas; livres = 12.
14	C	2/(2+5) = 2/7 • 28,6%.
15	D	16 12,5 = 200.
16	B	11 de Novembro de 1975.
17	C	Hino oficial.
18	D	Mbanza Kongo fica no Zaire.
19	C	Art. 198. -A da CRA.
20	B	Desconcentra o descentraliza o.
21	B	Lei n. 26/22 revogou a 17/90.
22	B	Art. 10. : nomea o a regra.
23	C	Resolu o n. 27/94.
24	C	Vantagem indevida = improbidade / falta de probidade.
25	B	Discri o + dados pessoais + sigilo cl nico.
26	C	Ordens criminosas n o obrigam.
27	C	SARS-CoV-2 causa COVID-19.
28	C	RT-PCR o padr o de refer ncia.
29	B	Vocabul rio cl nico cl ssico da COVID-19.
30	C	Lei n. 14/24 / DPA 2025.
31	C	Catete.
32	B	Mavinga (Menongue do Cubango).
33	C	Moxico Leste, sede Cazombo.
34	C	36 604 681 (INE).
35	C	3,5% ao ano.
36	D	65,5% urbana.
37	B	Luanda 8,8 milh es; Cuando 138 770.
38	B	32 *f* infantil; 16 neonatal; 52 infanto-juvenil.
39	D	40% (subiu face a 38%).

N.	Chave	Coment rio m nimo
40	C	49,8%.
41	B	Inqu rito amostral DHS/MICS.
42	C	IA como apoio, n o como desculpa tica.
43	B	Dados sens veis fora do sistema oficial.
44	B	Hino nacional.
45	D	Art. 200. da CRA.

Quadro 12 Chave das 45 quest es de treino.

DICA DE PROVA

Auto-avalia o: 40 45 certo = preparado; 32 39 = reveja as caixas MEMORIZE; 24 31 = refa a os cap tulos I, II, VII, VIII e IX; abaixo de 24 = recomece pelo plano de 14 dias, sem saltar exerc cios.

FONTES E LEGISLA O DE CONSULTA

Consulte sempre o texto oficial no Di rio da Rep blica ou nos portais do Estado. Este manual s ntese pedag gica.

Legisla o e normas

Constitui o da Rep blica de Angola (2010), com a revis o da Lei n. 18/21 T tulo V, arts. 198. a 200. -A.

Lei n. 26/22, de 22 de Agosto Lei de Bases da Fun o P blica (revoga a Lei n. 17/90).

Resolu o n. 27/94, de 26 de Agosto Pauta Deontol gica do Servi o P blico.

Lei n. 3/10, de 29 de Mar o Lei da Probidade P blica.

Lei n. 22/11, de 17 de Junho Protec o de Dados Pessoais.

Lei n. 14/24, de 5 de Setembro Divis o pol tico-administrativa (21 prov ncias, 326 munic pios, 378 comunas).

T picos do Concurso P blico de Ingresso Externo do MINSA (edi o em vigor no portal concurso-minsa.ao).

Estat stica e sa de

INE Resultados Definitivos e Relat rio-S ntese do Recenseamento Geral da Popula o e Habita o 2024.

INE / MINSA / DHS / UNICEF Inqu rito de Indicadores M ltiplos e de Sa de (IIMS) 2023 2024 (relat rio preliminar e final).

OMS defini es cl nicas e de sa de p blica da COVID-19; princ pios de tica da IA em sa de.

MINSA protocolos nacionais de COVID-19, PAV e normas de organiza o hospitalar vigentes.

UNESCO Recomenda o sobre a tica da Intelig ncia Artificial (2021).

Nota final ao candidato

O Secret rio Cl nico , muitas vezes, o primeiro rosto do Servi o Nacional de Sa de. A prova mede se o candidato conhece o Estado que vai servir, a tica que o vincula, o pa s que o Censo e o IIMS descrevem, e se pensa com clareza por palavras e por n meros. Estude com disciplina, chegue pontualmente, leia cada enunciado at ao fim e escolha a op o que a lei e os dados sustentam, n o a que soa mais bonita .

Fim do manual. Bom estudo e boa prova.

Edi o pedag gica de apoio 2026 Conte dos alinhados aos t picos oficiais do MINSA para Secret rio Cl nico.